GEHEIME BONUS

Melding van een kritieke bevinding: zo zeg je het aan de telefoon

Je hebt een kritieke bevinding gezien; nu moet je die aan de telefoon in 30 seconden zeggen, volledig en zonder misverstand. De structuur Situatie · Achtergrond · Beoordeling · Advies, 12 kant-en-klare gesprekken en wat je in het verslag vastlegt.

Inhoud

Wat is een kritieke bevinding en waarom bellen?

Gesprek in vier stappen: Situatie · Achtergrond · Beoordeling · Advies

Voor en na het gesprek

12 kant-en-klare gespreksvoorbeelden

Wat leg je vast in het verslag

Lastige situaties

Volgende stap

DEEL 1

Wat is een kritieke bevinding en waarom bellen?

De laatste schakel van de stap SAMENVATTEN: meld de spoedbevinding.

> *Het werk is pas klaar als de juiste arts de bevinding kent, niet als het verslag in het systeem staat.*

Een kritieke bevinding is een bevinding die, zonder directe interventie, het leven of een orgaan van de patiënt kan bedreigen. Welke bevindingen telefonisch worden gemeld, bepaalt de lijst van je instelling; hieronder staan voorbeelden die vaak op zulke lijsten voorkomen.

Neuro en wervelkolom

Intracraniële bloeding · massa-effect en herniatie · tekenen van een acuut herseninfarct · acute hydrocefalus · compressie van het myelum · instabiele wervelfractuur

Thorax

Pneumothorax passend bij spanning · longembolie · aortadissectie · verkeerd liggende tube of katheter · verdenking op tamponnade

Abdomen en pelvis

Vrije lucht · obstructie met tekenen van ischemie · AAA met tekenen van ruptuur · actieve bloeding · extra-uteriene zwangerschap · testis- of ovariumtorsie

Kinderen en overig

Invaginatie · corpus alienum of knoopbatterij in de slokdarm · elke onverwachte bevinding die de klinische beslissing verandert

Jouw regel als AIOS

Als je niet zeker weet of een bevinding kritiek is, meld het dan en overleg met je supervisor. Het meldingsprotocol van je afdeling gaat boven dit materiaal.

DEEL 2

Gesprek in vier stappen

Nederlandstalige versie van de SBAR-structuur: Situatie · Achtergrond · Beoordeling · Advies.

STAP	WAT JE ZEGT	SJABLOON
S · Situatie	Wie je bent, welke patiënt, de belangrijkste bevinding — in één zin.	«AIOS radiologie [je naam]. Bij [naam patiënt, patiëntnummer] is er op de [onderzoek] [bevinding].»
A · Achtergrond	Waarom en wanneer het onderzoek is gemaakt; de vraag op de aanvraag.	«Gemaakt om [tijdstip] bij [klinische situatie]; aanvraag «[vraag]».»
B · Beoordeling	Ernst van de bevinding: grootte, massa-effect, verandering ten opzichte van het vorige onderzoek.	«[Maat/graad]; op het vorige onderzoek [was er niet/was er wel].»
A · Advies	Wat je verwacht en het verzoek om terug te lezen.	«Ik adviseer [spoedbeoordeling / aanvullend onderzoek]. Kun je het teruglezen?»

Identiteit van de patiënt: twee identificatoren

Noem aan het begin van het gesprek de patiënt met minstens twee identificatoren (voor- en achternaam en patiëntnummer of geboortedatum). Patiënten met gelijkende namen zijn de meest voorkomende oorzaak van verwisseling.

Teruglezen

Vraag de andere partij om de bevinding en de patiënt te herhalen. Teruglezen is de eenvoudigste manier om aan de telefoon verwisseling van zijde en patiënt op te vangen.

DEEL 3

Voor en na het gesprek

30 seconden voorbereiding voordat je belt, één minuut vastleggen na het ophangen.

Voordat je belt

- [ ] Identiteit van de patiënt en onderzoek staan open op je scherm.
- [ ] Aanvragende arts of de op dat moment voor de patiënt verantwoordelijke arts vastgesteld.
- [ ] Bevinding, zijde en maat op papier of in het conceptverslag genoteerd.
- [ ] Vorig onderzoek gecontroleerd (nieuw of bekend?).
- [ ] Zo nodig is je supervisor op de hoogte gebracht.

Na het ophangen

- [ ] Melding vastgelegd in het verslag: tijdstip, aan wie (functie, afdeling), via welke weg.
- [ ] Vastgelegd dat er is teruggelezen.
- [ ] Als je instelling een registratiesysteem voor kritieke bevindingen heeft, is het daar ook ingevoerd.
- [ ] Verslag zonder vertraging in het systeem ingevoerd.

DEEL 4

12 kant-en-klare gespreksvoorbeelden

Vul de vierkante haken in; pas de zinnen aan je eigen spreektaal aan, behoud de volgorde.

01 Bevindingen passend bij een spanningspneumothorax

Bedside thoraxfoto, intensive care.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Bed/afdeling] je patiënt [naam patiënt, patiëntnummer] bij [uur] op de gemaakte thoraxfoto [rechts] zie ik een uitgebreide pneumothorax en verplaatsing van het mediastinum naar de andere zijde.
A · ACHTERGROND	Patiënt [geïntubeerd/na interventie]; aanvraag «[de vraag op de aanvraag]».
B · BEOORDELING	Bevindingen passend bij een spanningspneumothorax. Op de vorige foto pneumothorax [was er niet].
A · ADVIES	Ik adviseer de patiënt direct te beoordelen. Kun je de bevinding teruglezen?

Vastleggen in het verslag: «[Rechts] uitgebreide pneumothorax en radiologische bevindingen passend bij spanning. [Tijdstip] in [functie, afdeling] arts telefonisch gemeld, informatie bevestigd door teruglezen.»

02 Acuut epiduraal hematoom

Hoofdtrauma, spoedeisende hulp, CT hersenen zonder contrast.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. Op de SEH [naam patiënt, patiëntnummer]: op de CT hersenen [rechts temporaal] is er een acuut epiduraal hematoom.
A · ACHTERGROND	Gemaakt na hoofdtrauma; aanvraag «bloeding?».
B · BEOORDELING	Dikste plek [.. mm], midline shift [.. mm]; op [lineaire fractuur] aanwezig.
A · ADVIES	Mogelijk is een spoedbeoordeling door de neurochirurgie nodig; ik zet het verslag nu in het systeem.

Vastleggen in het verslag: «[Rechts temporaal] acuut epiduraal hematoom, [.. mm] middenlijnverschuiving. [Tijdstip] spoedeisende hulp [functie] arts telefonisch gemeld; er is teruggelezen.»

03 Subarachnoïdale bloeding

Plotseling ontstane hevige hoofdpijn, CT hersenen zonder contrast.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Naam patiënt, patiëntnummer] : op de CT hersenen zie ik een subarachnoïdale bloeding.
A · ACHTERGROND	Gemaakt bij plotseling ontstane hoofdpijn; traumaanamnese [geen].
B · BEOORDELING	Bloeding [in de basale cisternen] uitgebreid; hydrocefalus [afwezig/aanwezig].
A · ADVIES	Ik adviseer CT-angiografie in verband met een aneurysma; graag beoordeling samen met de betreffende afdeling.

Vastleggen in het verslag: «Subarachnoïdale bloeding; CT-angiografie aanbevolen. [Tijdstip] in [functie, afdeling] arts gemeld.»

04 Acuut ischemisch herseninfarct · hyperdense ACM

Stroke-code, CT hersenen zonder contrast.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. In het strokeprotocol [naam patiënt, patiëntnummer] : op CT geen bloeding; [links] Er is een hyperdens arterieteken in de ACM en er zijn tekenen van vroege ischemie.
A · ACHTERGROND	Begin van de symptomen op de aanvraag [uur] vermeld.
B · BEOORDELING	Geen bloeding gezien; [links] Vroege ischemische veranderingen in het stroomgebied van de ACM.
A · ADVIES	Ik adviseer beoordeling met CT-angiografie. Kun je de bevinding teruglezen?

Vastleggen in het verslag: «Geen intracraniële bloeding; [links] Hyperdens arterieteken in de ACM en tekenen van vroege ischemie. In het kader van het strokeprotocol [uur] in [functie, afdeling] arts gemeld.»

05 Longembolie

CT-pulmonalisangiografie, klinische patiënt.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Afdeling] je patiënt [naam patiënt, patiëntnummer] : op CT-pulmonalisangiografie is er een bilaterale longembolie.
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij dyspneu en tachycardie.
B · BEOORDELING	Embolieën [lobair en segmentaal] niveau; tekenen van rechterventrikelbelasting [aanwezig/afwezig].
A · ADVIES	Ik adviseer de patiënt te beoordelen; het verslag staat in het systeem.

Vastleggen in het verslag: «Bilaterale acute longembolie; tekenen van rechterventrikelbelasting [aanwezig/afwezig]. [Tijdstip] in [functie, afdeling] arts telefonisch gemeld.»

06 Aortadissectie

Pijn op de borst en in de rug, CT-angiografie.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. Op de SEH [naam patiënt, patiëntnummer] : op CT-angiografie is er een aortadissectie; aorta ascendens [betrokken/niet betrokken].
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij plotseling ontstane pijn op de borst en in de rug.
B · BEOORDELING	Dissectie [vanuit de aorta ascendens] beginnend [niveau] strekt zich uit tot; pericardeffusie [afwezig/aanwezig].
A · ADVIES	Mogelijk is een spoedbeoordeling door de cardiothoracale chirurgie nodig; kun je de bevinding teruglezen?

Vastleggen in het verslag: «[Stanford A] aortadissectie. Spoedbevinding; [uur] spoedeisende hulp [functie] arts gemeld, bevestigd door teruglezen.»

07 Pneumoperitoneum

Acute buik, staande thoraxfoto / CT abdomen.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Naam patiënt, patiëntnummer] : op het onderzoek zie ik vrije lucht onder het diafragma.
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij buikpijn; op de aanvraag recente chirurgische voorgeschiedenis [niet vermeld].
B · BEOORDELING	Vrije lucht [bilateraal]; op CT mogelijke plaats van perforatie [lokalisatie].
A · ADVIES	Ik adviseer een spoedbeoordeling door de chirurgie. Is er een recente chirurgische ingreep of interventie in de voorgeschiedenis?

Vastleggen in het verslag: «Pneumoperitoneum; passend bij perforatie van een hol orgaan. [Tijdstip] in [functie, afdeling] arts telefonisch gemeld.»

08 Verkeerd liggende maagsonde

Bedside röntgenfoto vóór de voeding.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Bed/afdeling] je patiënt [naam patiënt, patiëntnummer] : op de controlefoto van de maagsonde ligt de tip [rechter hoofdbronchus] geprojecteerd.
A · ACHTERGROND	Controle van de positie van de sonde aangevraagd vóór de start van de voeding.
B · BEOORDELING	Sonde niet in de juiste positie; [geen pneumothorax].
A · ADVIES	Ik adviseer de positie van de sonde te corrigeren voordat die wordt gebruikt. Kun je de bevinding teruglezen?

Vastleggen in het verslag: «Tip van de maagsonde [rechter hoofdbronchus] geprojecteerd, niet in de juiste positie. Vóór gebruik [uur] in [functie, afdeling] arts/verpleegkundige gemeld.»

09 Testistorsie

Plotse scrotale pijn, scrotale doppler-echo.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Naam patiënt, patiëntnummer] : op de scrotale doppler [links] zie ik geen flow in de testis.
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij plotseling ontstane scrotale pijn; begin [uur].
B · BEOORDELING	Bevindingen passend bij torsie; contralaterale testis normaal.
A · ADVIES	Ik adviseer een spoedbeoordeling door de urologie.

Vastleggen in het verslag: « [Links] bevindingen passend bij testistorsie. Kritieke bevinding; [uur] in [functie, afdeling] arts telefonisch gemeld.»

10 Bevindingen passend bij een extra-uteriene zwangerschap

Zwangerschapstest positief, echo van het bekken.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Naam patiënt, patiëntnummer] : op de echo van het bekken zie ik geen intra-uteriene zwangerschap; [rechts] is er een adnexmassa en vrij vocht.
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij een positieve zwangerschapstest en pijn in het bekken.
B · BEOORDELING	Bevindingen passend bij een extra-uteriene zwangerschap; vrij vocht [met echogene inhoud].
A · ADVIES	Ik adviseer een spoedbeoordeling door de gynaecologie. Kun je de bevinding teruglezen?

Vastleggen in het verslag: «Geen intra-uteriene zwangerschap gezien; [rechts] adnexmassa en vrij vocht, passend bij een extra-uteriene zwangerschap. [Tijdstip] in [functie, afdeling] arts gemeld.»

11 Compressie van het myelum

Bekende maligniteit, rugpijn, MRI thoracale wervelkolom.

S · SITUATIE	AIOS radiologie [je naam]. [Naam patiënt, patiëntnummer] : op de MRI van de thoracale wervelkolom [T..] niveau is er compressie van het myelum.
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij een bekende maligniteit en nieuwe rugpijn.
B · BEOORDELING	De compressie kan passen bij epidurale tumoruitbreiding; signaalverandering in het myelum [aanwezig/afwezig].
A · ADVIES	Ik adviseer een spoedbeoordeling; beeldvorming van de gehele wervelkolom [gedaan/mogelijk nodig].

Vastleggen in het verslag: « [T..] op niveau laesie mogelijk passend bij epidurale tumoruitbreiding en compressie van het myelum. [Tijdstip] in [functie, afdeling] arts telefonisch gemeld.»

12 Invaginatie (kind)

Intermitterende buikpijn, echo abdomen.

S · SITUATIE	AIOS radiologie **[je naam]**. Op de kinder-SEH **[naam patiënt, patiëntnummer]** : op de echo abdomen **[ileocolisch]** zie ik een invaginatie.
A · ACHTERGROND	Aangevraagd bij intermitterende buikpijn en braken.
B · BEOORDELING	**[In de rechter buikhelft]** target-teken; flow in de wand **[behouden/verminderd]**, vrij vocht **[afwezig/aanwezig]**.
A · ADVIES	Ik adviseer een spoedbeoordeling door de kinderchirurgie.

Vastleggen in het verslag: « **[Ileocolisch]** bevindingen passend bij invaginatie. Kritieke bevinding; **[uur]** in **[functie, afdeling]** arts gemeld.»

HOOFDSTUK 5

Wat leg je vast in het verslag

Een melding die niet is opgeschreven, is achteraf niet te verifiëren.

ITEM	VOORBEELD
Wat is gemeld	De kritieke bevinding uit de Conclusie, met dezelfde woorden als in het verslag.
Tijdstip	«om [tijdstip]» — en ook de datum als die niet uit het verslag zelf blijkt.
Aan wie	Functie en afdeling: «dienstdoende arts van de spoedeisende hulp», «verantwoordelijke arts van [afdeling]». Of je een naam noteert, hangt af van de praktijk in je instelling.
Via welke weg	Telefonisch / persoonlijk.
Bevestiging	«Informatie bevestigd door teruglezen.»

Sjabloon voor de registratiezin

«[Bevinding]. Om [tijdstip] telefonisch gemeld aan de arts van [functie, afdeling], informatie bevestigd door teruglezen.»

HOOFDSTUK 6

Lastige situaties

De telefoon wordt niet altijd bij de eerste poging opgenomen.

SITUATIE	WAT JE DOET
Je kunt de aanvragende arts niet bereiken	Neem contact op met de arts die op dat moment verantwoordelijk is voor de patiënt of met de dienstdoende van de afdeling; volg de escalatievolgorde van je instelling. Leg de pogingen en tijdstippen vast; breng je supervisor op de hoogte.
De andere partij kent de bevinding al	Meld het toch kort en leg het vast als «bevestigd als bekende bevinding»; vermeld vooral de verandering ten opzichte van het vorige onderzoek.
Je bent niet zeker van de bevinding	Stel de melding niet uit; overleg direct met je supervisor. Zeg ook aan de telefoon duidelijk hoe zeker je bent: «passend bij», «verdacht».
Het gesprek loopt uit of wordt een discussie	Ga terug naar de vier stappen, herhaal het advies en betrek je supervisor erbij. De klinische beslissing ligt bij het klinisch team; jouw taak is de bevinding correct en tijdig over te brengen.
Voorlopig verslag tijdens de nachtdienst	Een kritieke bevinding wordt ook in een voorlopig verslag op dezelfde manier gemeld en vastgelegd; verandert er na het definitieve verslag iets, dan wordt opnieuw gemeld.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Ga nu terug naar Hoofdmateriaal · 120 kant-en-klare verslagsjablonen. Vul de meldingszinnen in het veld Conclusie van de sjablonen voor spoedbevindingen in met het registratiesjabloon uit deze sectie.

Voor alle conclusiezinnen bij spoedbevindingen **Bonus 1 · Bank Met 200 Conclusiezinnen** kun je de zinnen met het label «Spoed» bekijken.